

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA*J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.***FARINGOAMIGDALITIS AGUDA**Bacteriana**Introducción**

Agente causal: Streptococo b hemolítico Grupo A

Clínica:

- Inicio brusco
- Odinofagia, fiebre y MEG
- Ausencia de tos y rinorrea

Exploración:

- Hipertrofia de amígdalas con exudado purulento
- Adenopatías yugulodigástricas bilaterales dolorosas
- Leucocitosis con neutrofilia

Diagnóstico

Clínico + cultivo SHBA + (70%)

Tratamiento En Urgencias

Penicilinas V oral o Benzatina IM. Amoxicilina-clavulánico o cefalosporina. Alérgicos: eritromicina/claritromicina o clindamicina.

Vírica**Introducción**

Agente causal: adenovirus, rinovirus

Diagnóstico

Clínica:

- Más frecuente
- Epidemia de comunidad (primavera/verano)
- Odinofagia sin MEG. Acompaña síntomas catarrales

Exploración:

- Eritema en orofaringe sin exudado pultáceo
- No adenopatías
- Linfocitosis/linfopenia

Tratamiento

Reposo y sintomático.

Esquema de tratamiento de las faringoamigdalitis

	Tratamiento	Alternativas	Otros tratamientos

Faringoamigdalitis aguda	Penicilina Amoxicilina Amoxicilina-ácido clavulánico Cefalosporinas orales ¹	Azitromicina Claritromicina	Clindamicina
Faringoamigdalitis recurrente	Amoxicilina-ácido clavulánico		Cirugía
Todas las faringoamigdalitis en que los betalactámicos no sean adecuados	Miocamicina Azitromicina Claritromicina		

CONSENSO FARINGOAMIGDALITIS (2003)*

Amigdalitis específicas

1. ANGINA DE PAUL-VINCENT

Introducción

A la exploración orofaríngea se aprecia una angina ulcerada cubierta de una membrana amarillenta, se asocia a lesiones en cavidad oral y encías como gingivitis y pericoronaritis.

- Agente causal: Bacterias fusospirales (*Borrelia Vincentii*) producida por la infección conjunta por *Fusobacterium* y *Treponema microdentium*.
- Angina unilateral ulceronecrótica irregular
- Afecta adultos jóvenes con mala higiene bucal

Clínica:

- Astenia+ aliento fétido+ adenopatía cervical dolorosa
- Puede producir Síndrome Lemierre

Exploración: amigdalitis unilateral, olor fétido, boca séptica

Diagnóstico

Muestra faríngea + exploración

Tratamiento

- Penicilina G o V, amoxicilina-clavulánico o cefuroxima
- Analgesicos tipo paracetamol y AINEs tipo ibuprofeno.
- Avisar a ORL

2. ANGINA DE LUDWIG

Introducción.

Es una infección de los tejidos blandos del cuello y piso de la lengua, colección purulenta debajo de la lengua, entre el músculo milohioides y el plano cutáneo del suelo de la boca. Afecta la vía aérea por su avance rápido y silencioso, puede llegar a ser mortal. Es rara y poco frecuente.

Principales factores que contribuyen en su origen desde deficiente higiene dental, extracción de piezas dentales, infecciones de encías, infecciones por piercing linguales hasta pacientes inmunocomprometidos.

Es una infección polimicrobiana desde flora normal y otros: anaerobios, *Streptococcus viridans*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Fusobacterium* y *Bacteroides*.

Origen: dental o de mandíbula, la infección se inicia en la parte inferior de la boca, generalmente en el segundo o tercer molar de la mandíbula, se propaga rápidamente a estructuras sublinguales y submandibulares.

Diagnóstico.

Es clínico y se confirma con pruebas complementarias:

- Hemograma, bioquímica con PCR / Procalcitonina y coagulación
- TC craneal/facial/cuello.

Clínica característica: eritema submandibular, induración y edema, dolor, fiebre, dificultad para la deglución y cerrar la boca, malestar general, rigidez de cuello, babeo, ronquera y disnea por edema de laringe. Si hay estridor y cianosis son signos de mal pronóstico. En la exploración física: se observa en orofaríngea una tumoración en el suelo de la boca con edema de la lengua.

Tratamiento.

Medidas generales en urgencias.

- Constantes vitales, canalizar vía venosa periférica.
- Asegurar vía aérea con oxigenoterapia según corresponda desde gafas nasales, ventimax con reservorio hasta traqueostomía de emergencia.
- Suero terapia, analgesia, AINES.
- Antibioticoterapia: Penicilina G sódica más metronidazol o clindamicina (cubrir anaerobios).

Medidas específicas.

- Avisar a ORL.
- Drenaje quirúrgico.
- Ingreso

3. HERPANGINA**Introducción**

Afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños 1 - 7 años . La enfermedad deja inmunidad persistente, pero puede presentar nuevos episodios por otros coxsackievirus A u otros enterovirus.

Agente causal: enterovirus, coxsackie grupo A.

Clínica: se caracteriza por aparición súbita de Fiebre alta + odinofagia+ úlceras o vesículas en pilar anterior amigdalár, paladar blando, las amígdalas, la úvula o la lengua

**Diagnóstico**

El diagnóstico se basa en la clínica: los síntomas y las lesiones características en boca.

Tratamiento

Sintomático e higiene bucal adecuada.

4. SÍNDROME MANO-BOCA-PIE.**Introducción**

Coxsackie A., enterovirus u otros enterovirus.

Clínica: La infección produce una erupción vesiculosa en la mucosa y la piel. Faringitis vesiculosa + erupción palmas y plantas.

Diagnóstico.

Es clínico.

Tratamiento.

Sintomático.

Nota

- No afecta cavidad bucal

5. DIFTERIA**Introducción**

Corynebacterium diphtheriae

Clínica: fiebre+debilidad+ malestar+disfagia

Exploración física: Pseudomembrana blanquecina que NO desprende y que cubre, amígdalas, úvula pilares y velo. (Inicio habitualmente en amígdala)

Puede causar problemas obstructivos

**Diagnóstico**

Cultivo faringoamigdalino

Tratamiento

- Penicilina/eritromicina y toxoide diftérico
- Si sospecha alta: antitoxina diftérica

Prevención: Vacuna (tétanos+ difteria+ tos ferina)

Nota

- Aumento de casos por la disminución de la vacunación y la inmigración.

Bibliografía

- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2015.
- Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2ª Edición. Carlos Suárez Nieto et al.
- Dorothy S. Carlson, Ellen Pfadt. Angina de Vincent y angina de Ludwig: dos infecciones orales peligrosas. Nursing 2011, mayo 21 : <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-angina-vincent-angina-ludwig-dos-0212538211702291>